

[우리 가치(WeValue)] 스마트 소통 실무 안내문 (v1.0)

본 안내문은 협업 보조 수단이며, 모든 공식 처방과 지시는 원내 전산 시스템(EMR) 기록을 원칙으로 합니다.

1. 스마트 소통 5대 약속 (WeValue 5-Promises)

가. [표준] 메시지 첫머리 [병실/성함] 기재

- PA가 환자를 즉각 식별하여 신속히 대응할 수 있도록 필수 정보를 서두에 배치합니다.
- 예시: 1305/홍길동 약물 처방 확인 바랍니다.

나. [회진] 결정 사항의 선제적 공유 (PA → 병동)

- 회진 후 발생하는 긴급 결정 사항은 유선 연결이 어렵더라도 메신저로 즉시 사전 알림을 전송하여 업무 공백을 방지합니다.

다. [자가약] '진행 상태' 중심의 요약 공유

- 처방 필요 여부, 복용 현황 등 실무 상태 위주로 공유하며, 식별이 불가능한 사진 보고나 단순 텍스트 나열은 지양합니다.

라. [제외] 공식 채널(EMR/유선) 활용 원칙

- 수술/시술 결정, 중요 검사 결과(CV) 등 중대 의사결정은 반드시 전산 시스템 및 공식 유선/SMS 채널을 이용합니다.

마. [매너] [답장(Reply)] 기능 활용

- 확인 시 [답장] 버튼을 눌러 "네, 확인했습니다"라고 입력함으로써 소통의 완결을 알리고 불필요한 유선 전화를 차단합니다.

2. 부서별 맞춤 운영 모델 (Four-Track Strategy)

구분	대상 부서	운영 모델	핵심 소통 방식
통합	92병동(CS/MC)	통합형	파편화된 도구(SMS 등) 지양, 공통 단체방 으로 채널 단일화
집중	131병동(URO)	집중형	업무 복잡도 대응을 위한 1:1 개인 메신저 표준 프로토콜 적용
특화	131 병동 ENT / 141 단기항암	특화형	3교대 특성을 반영하여 기존 전용 단체방 유지 및 답장 기능 강화
안정	14층 (MH)	안정화	기존의 효율적인 개인 메신저 방식을 존중하며 시각 가이드 중심 운영

3. 안전 및 보안 수칙 (단계별 대응 지침)

- 가. 단계별 대응 (10분 룰): 메시지 발송 후 10분 내 [답장]이 없거나 상대방이 로그아웃 상태일 경우 즉시 유선 전화로 전환합니다.(시간은 부서별 특성에 맞춰 유연하게 조정)
- 나. 응급 상황 우선순위: 실시간 확인이 필요한 응급 상황은 메신저 대신 항상 유선 전화(Call)를 최우선으로 합니다.
- 다. 정보 보안 엄수: 업무 목적 외의 화면 캡처, 촬영, 외부 반출을 엄격히 금지하며 병원 보안 규정을 준수합니다.
- 라. 오류 즉시 정정: 정보 오발송 시 '메시지 삭제' 기능을 활용하고 즉시 정정 메시지를 게시하여 혼선을 방지합니다.